

NOTAS EXPLICATIVAS

Guarde la tarjeta de información para el paciente y llévela consigo cada vez que visite al médico.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN OBJETIVA

Se presentó con disnea de esfuerzo, ortopnea e hinchazón de los miembros inferiores. En la radiografía de tórax se observó un derrame pleural del lado derecho.

Examen clínico: TA = 160 / 80, SpO2 = 92 % (en aire)

Antecedentes personales: cardiopatía coronaria, marcapasos, enfermedad arterial coronaria previa, enfermedad carotídea sometida a cirugía

MARCHA DE LA ENFERMEDAD

El paciente fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde se le administró un diurético intravenoso con furosemida y se le privó de líquidos (diuresis por punción diagnóstica). A lo largo de su internación, se registraron balances negativos. En un segundo examen de diagnóstico por imágenes, se observó una mejora en la acumulación pleural. Se lo dio de alta con un estado hemodinámico estable y sin fiebre, según las indicaciones.

DIAGNÓSTICO DE SALIDA

Insuficiencia cardíaca; derrame pleural no evolutivo; estenosis valvular aórtica severa

INSTRUCCIONES DE SALIDA - NOTAS

1. Consumo total de agua en 24 horas: hasta 1.5 litros
2. Dieta baja en sal
3. Conducción cuidadosa

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE SALIDA

- lepur tb 40 1x1 noche
- tb eliquis 5 1x2
- zylapour_tb_300_1x1_tarde
- tblordin 1 x 1 por la mañana 20 minutos antes del desayuno
- carbapenem 6.25 mg 1 x 2
- tb Triatec 2.5 1 x 1 mañana
- Lasix 2 x 2 durante 3 días y luego 1 x 2.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Hct

37

SGOT

22

LDL

Ferritina

Hb

11.6

SGPT

12

INR

WBC
7.800
g-GT
Álbumes
7.3
PLT
313.000
BILT
Albúmina
3,3
TROP
Hasta 0.09
ALP
TSH
GLU
86
CPK
135
FT4
UREA
78
LDH
225
TKE
CREAT
1,5
CHOL
Ácido úrico
K
3,6
TRIGL
B12
Na
137
HDL
Fullico

EXÁMENES

Electrocardiograma de salida

Ritmo sinusal, 80 lpm

Tórax (entrada)

Empeoramiento del EPOC con hipoventilación alveolar en la parte inferior del pulmón izquierdo. Calcificaciones de la aorta torácica. Leve empeoramiento de la EPOC en los pulmones izquierdos.

Ecocardiografía

LV de dimensiones normales con buen espesor de pared y EF del 45 al 50%. Arteria descendente y aórtica

normales. Severa estenosis de la arteria descendente anterior (0.8 cm² de área ocluida). Leve arterioesclerosis. Calcificaciones en la arteria coronaria descendente posterior (MR 2+). TR3+ con presión de llenado ventricular izquierdo de 60 mmHg. Dilatación auriculoventricular. Pericardio libre.